

Zdravje v Občini Črnomelj: kje smo, zakaj, in kaj lahko naredimo

Kaj o zdravju prebivalcev Občine Črnomelj dejansko povedo uradni podatki NIJZ za zadnjih enajst let (2016–2026) — kje se stanje izboljšuje hitreje od slovenskega povprečja, kje zaostaja, zakaj do tega verjetno prihaja, in kako center za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Črnomelj s preventivo naslavlja te izzive.

To poročilo je namenoma sestavljeno tako, da ne ponuja pavšalne slike "vse je slabo" ali "vse je v redu" — podatki kažejo oboje, odvisno od kazalnika, in to razliko je vredno razumeti pred vsakim ukrepanjem.

Viri: NIJZ (54 časovnih nizov, 2016–2026), Zdravstveni dom Črnomelj, Center za krepitev zdravja Črnomelj, Eurostat/OECD

Geografski okvir: Občina Črnomelj, primerjalno regija JV Slovenija in Slovenija

KAZALO POROČILA

- | | |
|--|---|
| 1. Povzetek za bralca | 8. Zakaj prihaja do teh problemov |
| 2. Zdravstveni dom Črnomelj — ustanova | 9. Kako jih rešiti |
| 3. Družbeno-gospodarski kontekst | 10. Center za krepitev zdravja Črnomelj |
| 4. Dejavniki tveganja skozi čas | 11. V evropskem ogledalu |
| 5. Presejalni in preventivni programi | 12. Zaključek in priporočila |
| 6. Kronične bolezni in zapleti | 13. Literatura |
| 7. Umrljivost skozi čas | |

01 Povzetek za bralca

To poročilo temelji na neposrednem branju **24 od 54 uradnih časovnih nizov NIJZ** "Zdravje v občini" za Občino Črnomelj — vsak niz pokriva polnih enajst let, ločeno za občino, regijo Jugovzhodna Slovenija in Slovenijo. Štiri ugotovitve izstopajo:

EDINI DOSLEDEN
ZAOŠTANEK

Otroci

Prekomerna prehranjenost otrok je edini kazalnik, ki je v vseh 11 letih brez izjeme nad slovenskim povprečjem.

PRESENETLJIV
PREOBRAT

3 kazalniki

Srčna kap, možganska kap in z alkoholom pripisljive bolezni so iz nadpovprečja prešli v enakost ali podpovprečje.

VODILNI PRESEJALNI
PROGRAM

DORA

Presejanost raka dojke je od 2021 dosledno nad slovenskim povprečjem (82,1 % proti 77,9 % leta 2026).

NESPREMENJENO
DESETLETJE

0,90

Indeks razvitosti občine (1,00 = slovensko povprečje) se v enajstih letih ni premaknil niti za odstotek.

Preostanek poročila te ugotovitve razčleni po kazalnikih, s polnimi grafi po letih, nato razloži verjetne vzroke in možne rešitve, ter posebej oceni delo Centra za krepitev zdravja (CKZ) pri Zdravstvenem domu Črnomelj — enote, ki je formalno zadolžena prav za preventivo teh istih problemov.

02 Zdravstveni dom Črnomelj – ustanova

kadrovsko pod pritiskom

Zdravstveni dom Črnomelj je javni zavod, ustanovljen 1996, ustanoviteljica Občina Črnomelj; pokriva tudi Občino Semič – skupaj približno 18.700 prebivalcev na 487 km², razpršenih po 173 naseljih, z najbližjo bolnišnico 45 km stran. Zavod deluje na treh lokacijah (Črnomelj, ZP Semič, ZP Vinica).

Ključni podatki, uradno letno poročilo 2025

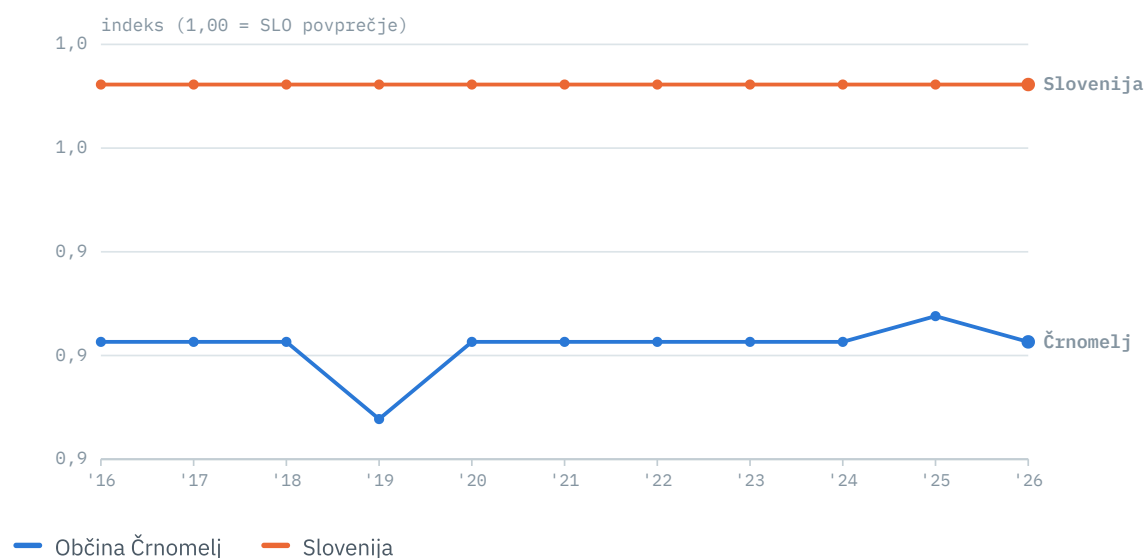
POSTAVKA	VREDNOST
Prihodki	9.753.579 € (88,9 % ZZSZ)
Odhodki	9.457.216 € (+18,7 % na leto)
Poslovni izid	+296.363 € (marža se krči – prihodki +15,8 %)
Zaposleni konec 2025	145 (13 odhodov, 21 novih zaposlitev)
Zadovoljstvo pacientov	4,57 / 5
Kadrovska vrzel	Družinska medicina, pediatrija, urgencia, zobozdravstvo, psihologija – zavod sam potrjuje kot strukturno , ne sezonsko

Vir: Zdravstveni dom Črnomelj, letno poročilo 2025. Polni zapis, vključno z vodstveno krizo zavoda: wiki stran *Zdravstveni dom Črnomelj: kritični pregled*.

03 Družbeno-gospodarski kontekst

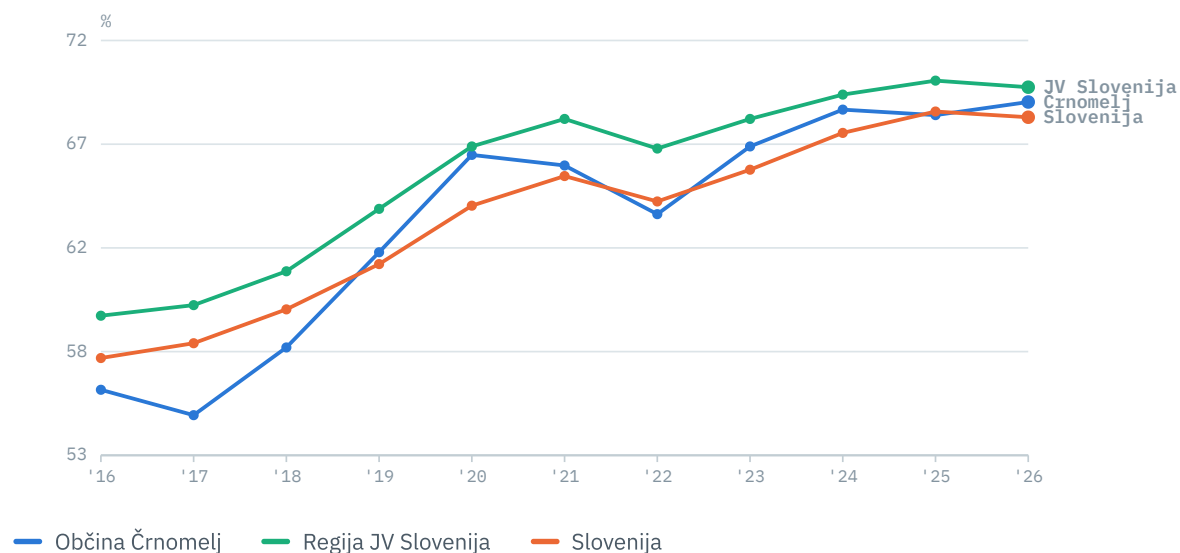
Preden pogledamo zdravstvene kazalnike same, je vredno pogledati, na kakšnih družbeno-gospodarskih temeljih stojijo. NIJZ za vsako občino izračuna tudi indeks splošne razvitosti (dohodek, izobrazba, brezposelnost, demografija) — kazalnik, ki je v javnozdravstveni literaturi eden najbolj uveljavljenih napovednikov splošnega zdravja populacije [1].

K1.1 · Razvitost občine



► Podatki v tabeli

K1.5 · Stopnja delovne aktivnosti



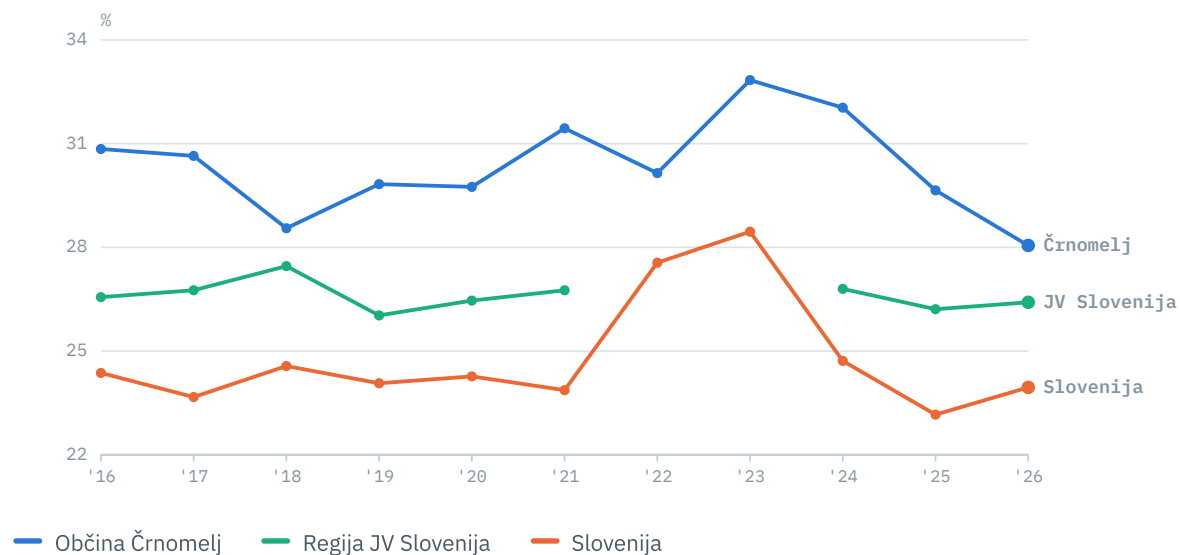
► Podatki v tabeli

Zanimivo: medtem ko je razvitost občine ostala nespremenjena, se je stopnja delovne aktivnosti izrazito izboljšala (+13,6 odstotne točke v desetletju) in je leta 2026 **prvič presegla slovensko povprečje**. To je pomemben, redko izpostavljen pozitiven premik, ki kaže, da "nižja razvitost" ni statičen usod, temveč se vsaj nekateri njeni sestavni deli lahko izboljšajo.

04 Dejavniki tveganja skozi čas

Dejavniki tveganja so vedenja in stanja, ki neposredno povečujejo verjetnost kasnejše bolezni – prehrana, gibanje, alkohol, kajenje. Tu se pokaže najbolj trdovraten problem v celotnem poročilu [1].

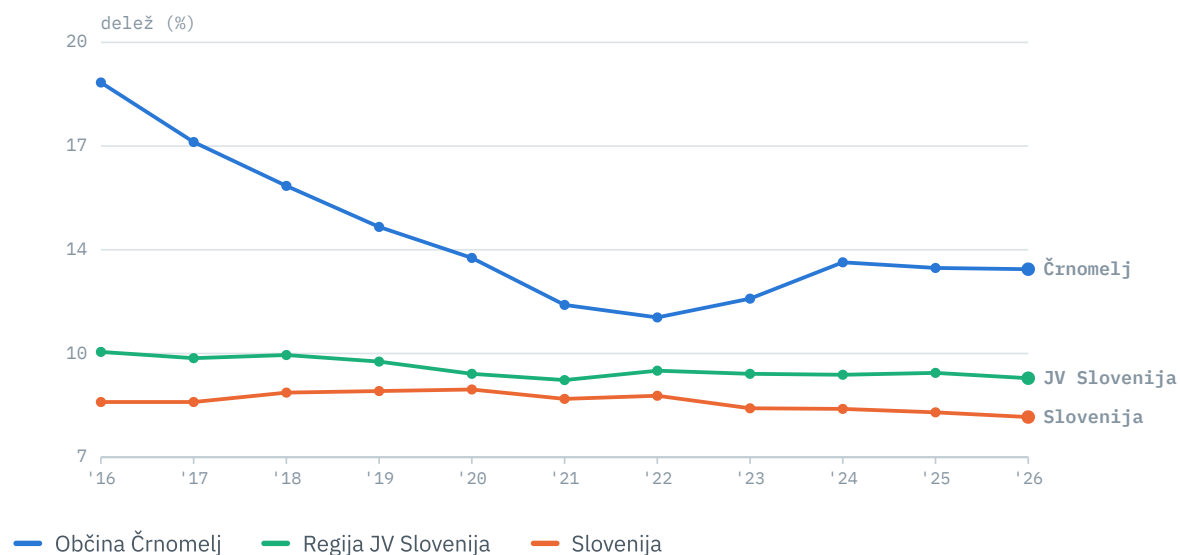
K2.2 • Prekomerna prehranjenost otrok



► Podatki v tabeli

Edini kazalnik brez izjeme: v vseh 11 pregledanih letih je prekomerna prehranjenost otrok v Črnomlju višja od slovenskega povprečja, razlika se giblje med 4 in skoraj 9 odstotnimi točkami. To je edini kazalnik v tem poročilu, kjer se občina niti v enem samem letu ni približala povprečju.

K2.6 • Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji



► Podatki v tabeli

Izboljšanje, a ne dovolj: delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji se je od 2016 skoraj prepolovil (18,9→12,9), a ker se je v istem času izboljšala tudi Slovenija, občina ostaja približno 57 % nad državnim povprečjem.

▼ Dodatni dejavniki tveganja (kadilci, opijanje, marihuana, prehranjenost odraslih) – podatki v tabeli

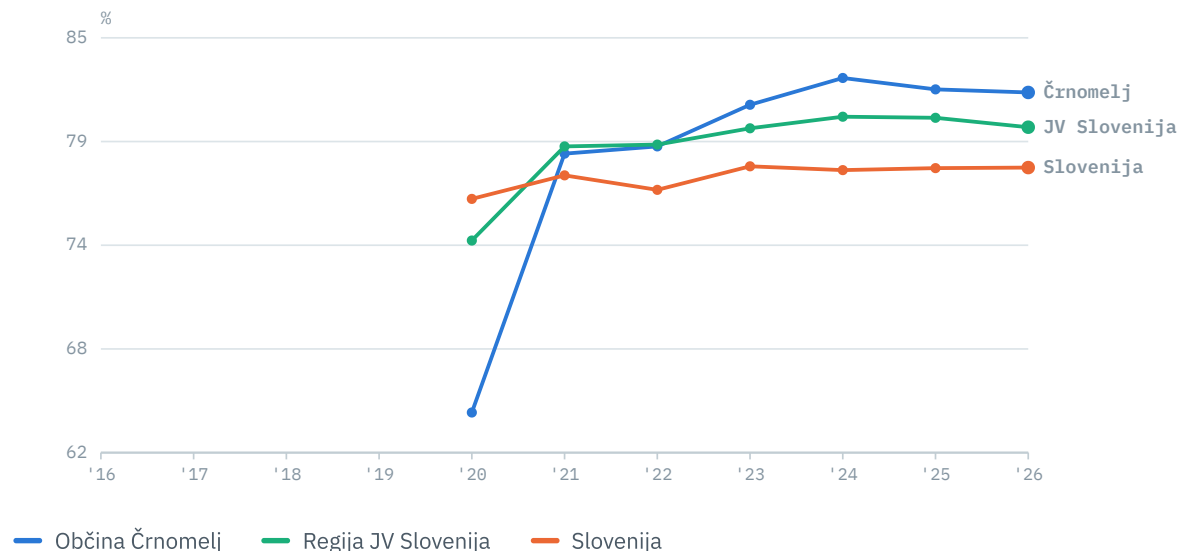
KAZALNIK	PRVI PODATEK	ZADNJI PODATEK	SLOVENIJA (ISTO LETO)
Kadilci, odrasli	25,6 % (2016)	23,7 % (2021)	23,2 % (2021)
Prekomerna prehranjenost odraslih	63,95 % (2019)	61,64 % (2026)	59,78 % (2026)
Visokotvegano opijanje	44,7 % (2016)	46,2 % (2021)	42,8 % (2021)
Uporabniki marihuane	20,4 % (2020)	14,04 % (2026)	21,96 % (2026, občina zdaj pod povprečjem)

05 Presejalni in preventivni programi

svetla točka

Presejalni programi so edino področje v tem poročilu, kjer Občina Črnomelj dosledno izstopa navzgor.

K3.4 • Presejanost v programu DORA (rak dojke)



► Podatki v tabeli

DORA vodi: odzivnost žensk v presejalnem programu za raka dojke je od 2021 dalje vsako leto višja od slovenskega povprečja — leta 2026 82,1 % proti 77,9 %. To je najbolj dosledna pozitivna zgodba v celotnem naboru podatkov.

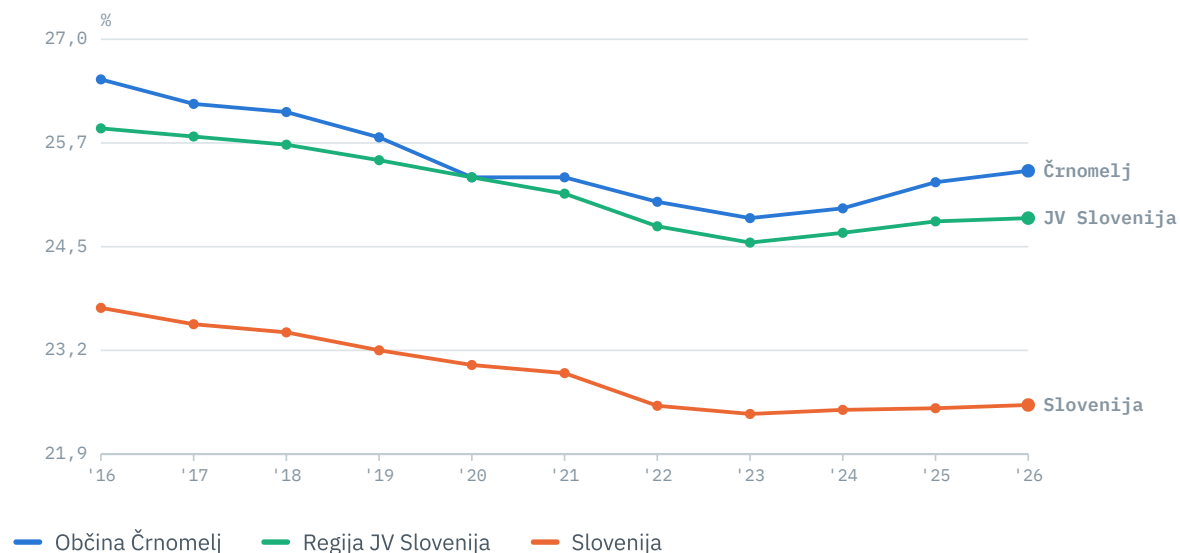
▼ Svit, Zora in precepljenost — podatki v tabeli

PROGRAM	PRVI PODATEK	ZADNJI PODATEK	SLOVENIJA (ZADNJE LETO)
Svit (rak debelega črevesa)	64,9 % (2016)	68,14 % (2026)	64,94 % – nad povprečjem
Zora (rak materničnega vratu)	74,3 % (2016)	71,96 % (2026)	72,48 % – rahlo pod povprečjem
Precepljenost OMR	88,51 % (2025)	88,10 % (2026)	86,94 % – nad povprečjem
Precepljenost DTP-Hib-IPV-hepB	79,73 % (2025)	83,33 % (2026)	85,61 % – pod povprečjem, a v porastu

06 Kronične bolezni in zapleti

Tu se pokaže najbolj protislovna, a hkrati najbolj upanja polna slika v celotnem poročilu: dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni (krvni tlak) ostajajo nad povprečjem, a njihovi najhujši akutni zapleti (srčna in možganska kap) so se izboljšali hitreje kot v Sloveniji kot celoti [1].

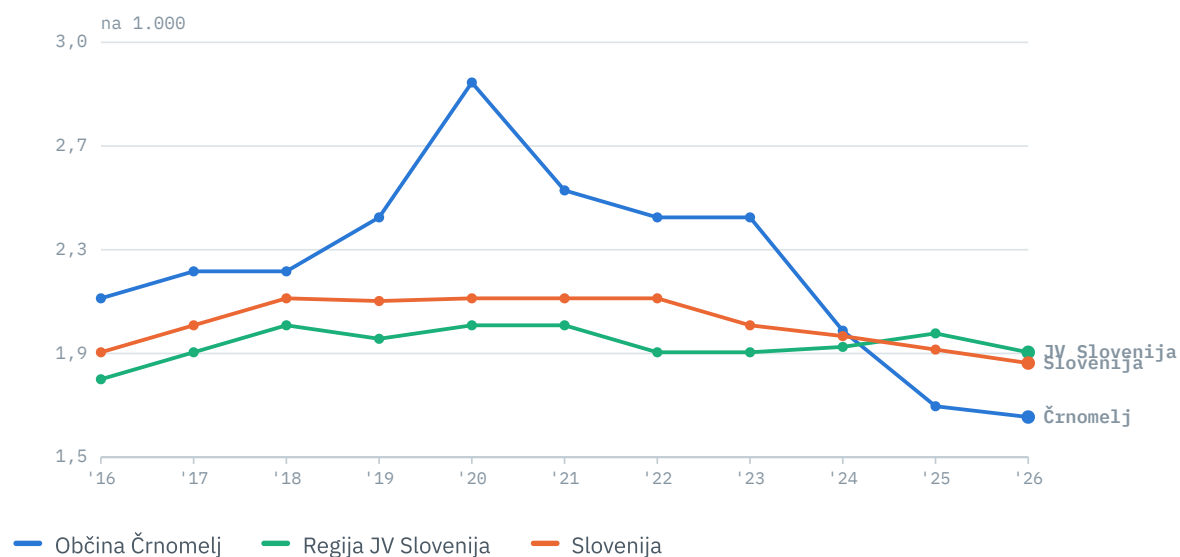
K4.6 · Prejemniki zdravil za povišan krvni tlak



► Podatki v tabeli

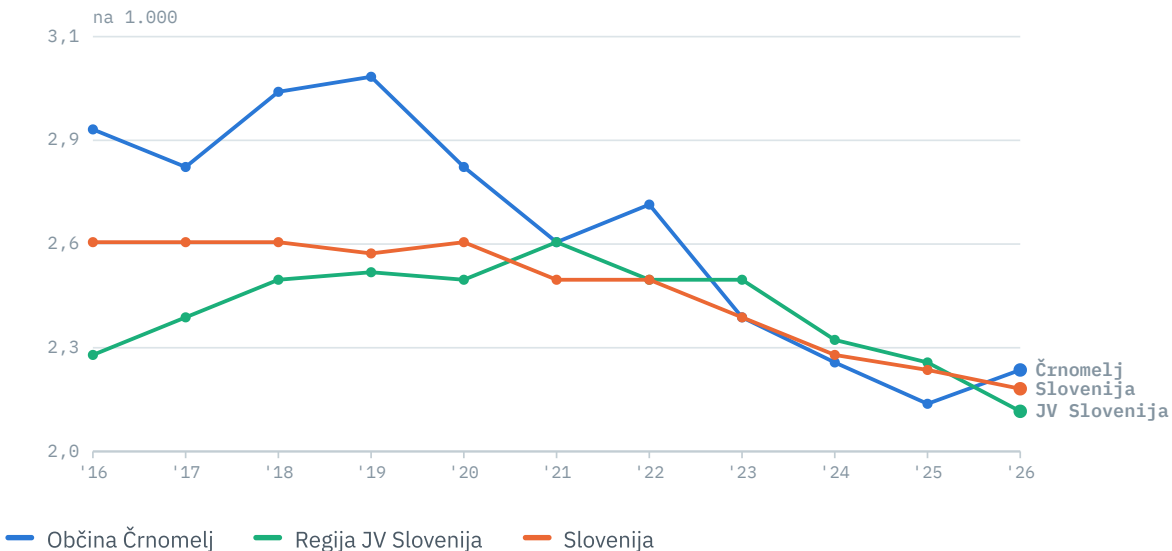
Vrzel, ki se ne zapira: delež oseb na zdravljenju za povišan krvni tlak je skozi celotno desetletje ostal približno 3 odstotne točke nad slovenskim povprečjem, brez znakov zblževanja.

K4.8 · Srčna kap (35–74 let)



► Podatki v tabeli

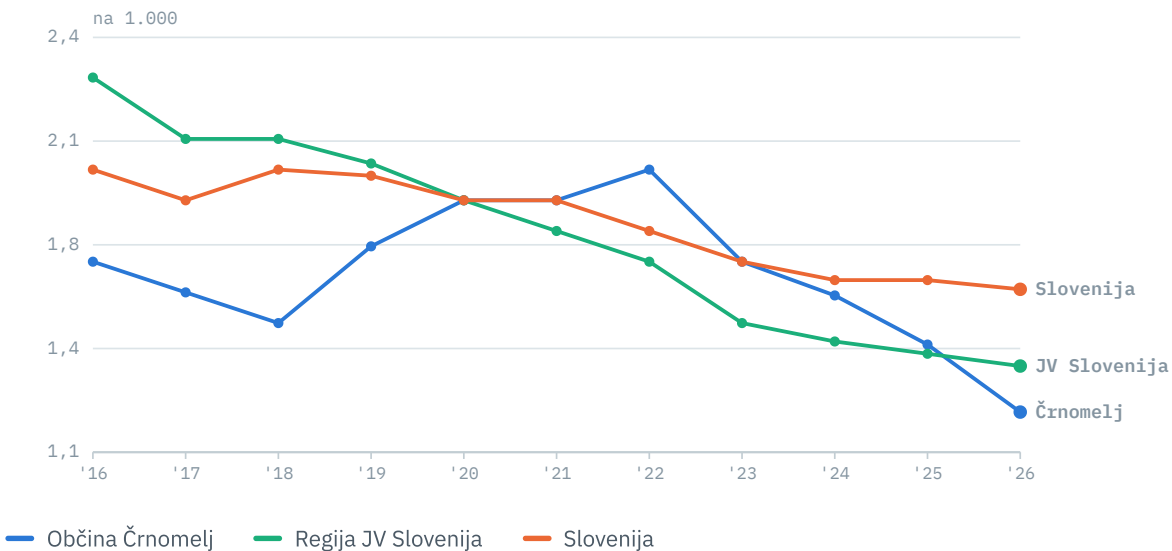
K4.9 · Možganska kap (35–84 let)



► Podatki v tabeli

Presenetljiv preobrat: tako srčna kap (35–74 let) kot možganska kap (35–84 let) sta bili v letih 2016–2022 dosledno nad slovenskim povprečjem; od 2024 dalje je občina pri obeh enaka ali boljša od povprečja. To je eden najbolj vzpodbudnih rezultatov v tem poročilu in vredno raziskati, kateri konkretni ukrepi so k temu prispevali.

K4.4 · Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15+)



► Podatki v tabeli

Enak vzorec preobrata: bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, so sledile isti poti — iz nadpovprečja (2016–2022) v jasno podpovprečje (2026: 1,21 proti slovenskim 1,61).

▼ Sladkorna bolezen, duševne motnje, bolniška odsotnost — podatki v tabeli

KAZALNIK	2016	2026	SLOVENIJA 2026
Prejemniki zdravil za sladkorno bolezen	5,4 %	5,72 %	5,47 %
Prejemniki zdravil za duševne motnje	16,5 %	15,64 %	14,47 %

KAZALNIK

2016

2026

SLOVENIJA 2026

Bolniška odsotnost (dni/leto)

11,6

19,17

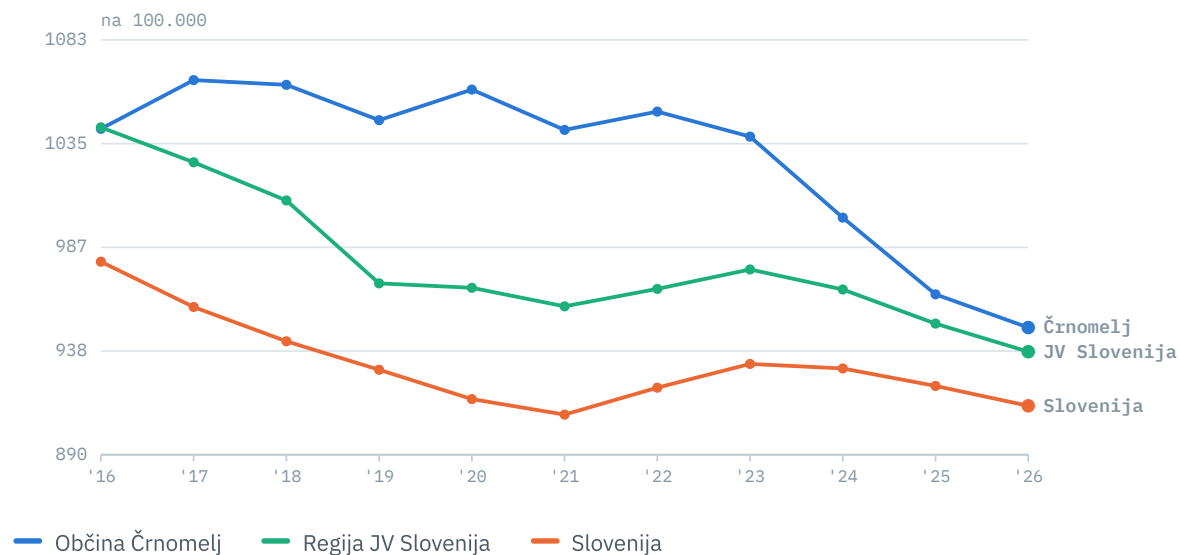
20,53 – občina zdaj **pod** povprečjem

07 Umrljivost skozi čas

osrednja skrb

Podatki NIJZ [1]: splošna umrljivost je najbolj celovit, a tudi najbolj počasi odzivni kazalnik zdravja populacije — nanj vplivajo vsi zgornji dejavniki skupaj, z večletnim zamikom.

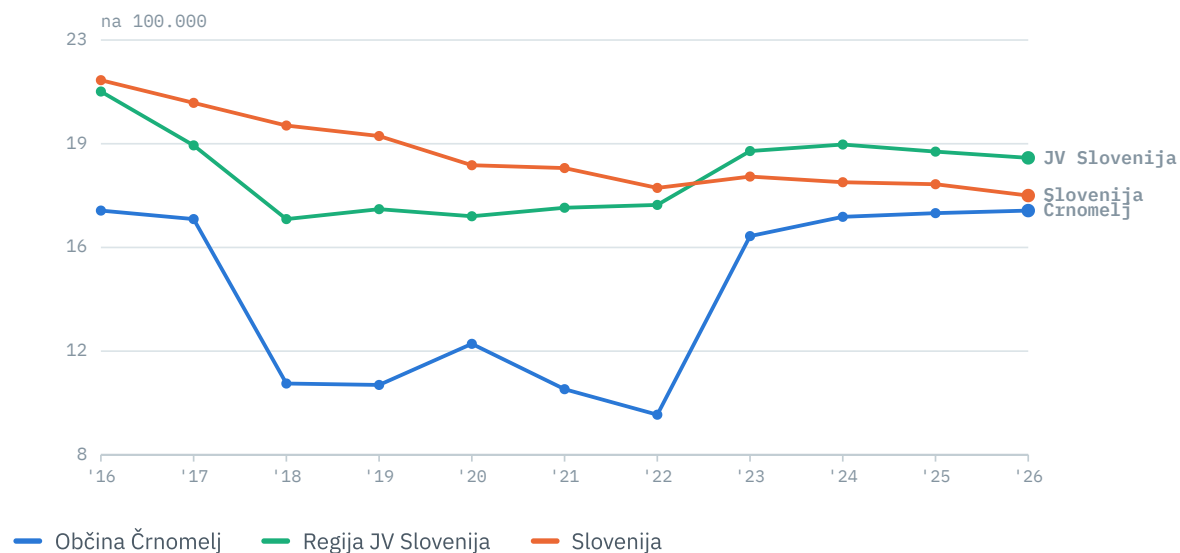
K5.1 • Splošna umrljivost



► Podatki v tabeli

Vrzel se zapira, a počasi: splošna umrljivost se je znižala v občini in v Sloveniji, a razlika med njima se je zmanjšala le z 6,3 % (2016) na 4,0 % (2026) — konsistentno nad povprečjem vseh enajst let.

K5.7 • Umrljivost zaradi samomora



► Podatki v tabeli

Velika nihajnost: umrljivost zaradi samomora niha med 9,9 in 17,1 na 100.000 iz leta v leto, brez jasnega trenda — pri majhni populaciji občine (~14.000) že nekaj primerov letno premakne stopnjo za več odstotkov. Občina je pri tem kazalniku dosledno pod regijskim in blizu ali pod slovenskim povprečjem, kar je pomembno, ker ima Slovenija samo najvišjo stopnjo samomorov v celotni EU (glej razdelek 11).

▼ Umrljivost zaradi bolezni obtočil in raka – podatki v tabeli

KAZALNIK	2016	2026	SLOVENIJA 2026
Srčno-žilna umrljivost (0–74 let)	94,1	70,0	62,8
Umrljivost zaradi raka (0–74 let)	163,2	141,9	140,9

08 Zakaj prihaja do teh problemov

Spodnja tabela povzema splošno uveljavljene javnozdravstvene razlage za vzorec zgornjih podatkov, prilagojene lokalnemu kontekstu. Gre za **interpretacijo**, ne za neodvisno dokazano vzročnost, specifično potrjeno za Občino Črnomelj – nobena pregledana raziskava ni izvedla lokalne vzročne študije.

VERJETEN DEJAVNIK	KAKO SE POVEZUJE S PODATKI	ZANESLJIVOST
Nižja socialno-ekonomska razvitost	Indeks razvitosti dosledno 0,90 proti 1,00 — uveljavljena povezava z več kajenja, slabšo prehrano, manj presejanja	visoka
Geografska oddaljenost in razpršenost	173 naselij, 487 km², najbližja bolnišnica 45 km — otežen dostop, a ne pojasni izboljšav pri srčni kapi	srednja
Strukturno pomanjkanje zdravnikov	Manj časa za preventivno svetovanje; ne pojasni, zakaj sta Svit in DORA nad povprečjem	srednja
Staranje prebivalstva	Občina starejša od Slovenije do 2023, nato izenačena — slabi razlago za najnovejše podatke	visoka (le za umrljivost)
Regionalni prehranski/pivski vzorci (Bela krajina, vinorodna regija)	Pogosto omenjena, a nikjer neodvisno kvantificirana hipoteza	nizka — Status: Unverified
Majhna populacija → statistični šum	Velika medletna nihanja pri samomoru in srčno-žilni umrljivosti pod 74 let so statistično pričakovana pri ~14.000 prebivalcih	visoka (statistično nujno dejstvo)

09 Kako jih rešiti

ROK	UKREP
Kratkoročno 0–12 mesecev	Letno javno objavljati posodobitev NIJZ kazalnikov z jasno označenim trendom (izboljšanje/poslabšanje/stagnacija); CKZ naj cilja specifično na prekomerno prehranjenost otrok — edini dosledno nadpovprečen dejavnik; primerjati, zakaj je DORA nad, Zora pa pod povprečjem, in prenesti dobro prakso med programoma.
Srednjeročno 1–3 leta	Ciljan program za zmanjšanje prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji (še vedno 57 % nad povprečjem); razširiti pristope, ki so verjetno izboljšali srčno/možgansko kap, na obvladovanje krvnega tlaka in sladkorne bolezni; nasloviti strukturno pomanjkanje zdravnikov.
Dolgoročno 3–10 let	Spremljati, ali se indeks razvitosti občine sploh kdaj premakne; izvesti regionalno raziskavo o domnevnih prehranskih/pivskih vzorcih namesto zanašanja na hipotezo; uvesti drseče večletno povprečje za kazalnike z veliko statistično nihajnostjo (samomor, srčno-žilna umrljivost pod 74 let).

10 Center za krepitev zdravja Črnomelj

aktiven, a netransparenten

Center za krepitev zdravja (CKZ) Črnomelj je samostojna organizacijska enota znotraj ZD Črnomelj, del nacionalne mreže **30 centrov za krepitev zdravja**, vzpostavljene v okviru programa NIJZ "Skupaj za zdravje" [9]. Izvaja vzgojo za zdravje, vzgojo za ustno zdravje, integrirano preventivo kroničnih bolezni ter krepitev zdravja za otroke, mladostnike in odrasle [4].

Center dejansko deluje — to je prva in najpomembnejša ugotovitev. Po uradnem letnem poročilu ZD Črnomelj za 2025 je bila na vseh osmih programskih področjih dela CKZ dosežena 100-odstotna realizacija predvidenih ur, center pa je sodeloval z okvirno **30 lokalnimi partnerji** (šole, vrtci, društva, obe občini, dom starejših, vojska in drugi) [3]. Dokumentirane ponavljajoče se aktivnosti vključujejo Festival zdravja (2023, 2025, 2026) [7][8], pohod "Rožnati koraki", "Brkati pohod" na Mirno goro, test hoje na Stadionu Loka, meritve krvnega tlaka in "Srčno pot Svibnik" [5].

Ključni podatki o delu CKZ Črnomelj (2025)

POSTAVKA	PODATEK
Programska področja	8 (priprava na porod, krepitev zdravja odraslih, vzgoja otrok/mladostnikov, ustno zdravje, individualni posveti, aktivnosti v skupnosti, šola za starše) — 100 % realizacija ur [3]
Kadrovska zasedba	Razpršena: 1,00 FTE integrirani CKZ, 1,00 FTE družinska obravnava, 0,85 FTE zobozdravstvena vzgoja, del 0,34 FTE dispanzerja za mentalno zdravje — brez enotnega prikaza skupaj [3]
Lokalni partnerji	~30 (šole/vrtci obeh občin, društva bolnikov, DSO, Slovenska vojska, KS, gasilska društva, Rdeči križ, CSD in drugi) [3]
Edini objavljeni kvantitativni izid delavnice	"Družinska obravnava za zdrav življenjski slog", 17 udeležencev: mišična masa izboljšana pri 82 %, maščobna masa zmanjšana pri 79 %, ITM znižan pri 64 % [3]
Referenčne ambulate (širša preventiva)	2025: 1.645 povabljenih, 1.366 pregledanih, 923 z odkritimi dejavniki tveganja (165 depresija, 144 sladkorna, 236 hipertenzija, 20 KOPB, 67 osteoporoza) [3]
Zadnja objava v arhivu "CKZ vabila"	3. 10. 2022 — skoraj štiri leta brez posodobitve, kljub dokumentiranim novjšim aktivnostim na ločeni podstrani [6]

Ocena dela CKZ po kriterijih

KRITERIJ	OCENA	UTEMELJITEV
Obseg in raznolikost aktivnosti	4/5	Dokumentirano sodelovanje z ~30 partnerji, ponavljajoči se dogodki, pokritost vseh starostnih skupin
Transparentnost dosega/rezultatov	2/5	Objavljen le kazalnik ene delavnice (17 oseb); ni skupnega letnega poročila o dosegu CKZ kot celote
Kadrovska preglednost	2/5	Razpršena sistemizacija brez enotnega prikaza; vodstvo ni jasno navedeno na uradni strani
Vzdrževanje spletne komunikacije	2/5	Arhiv vabil zastarel ~4 leta; napačna povezava na nacionalni program; urnik le kot slika
Vpetost v nacionalni sistem	4/5	Del mreže 30 CKZ; uradno vključen v nacionalni Program MIRA za duševno zdravje [12]

Kritična ocena: CKZ Črnomelj ni "papirnat" center — aktivnosti so resnične, dokumentirane in razmeroma raznolike. A ni mogoče kritično ovrednotiti njegove dejanske **učinkovitosti**: ne obstaja javno objavljen agregatni podatek o tem, koliko ljudi je center v celotnem letu dejansko dosegel, koliko je stal, kdo ga vodi, ali koliko je prispeval k gibanju NIJZ kazalnikov iz razdelkov 3–7 zgoraj. NIJZ sicer prek aplikacije eSZBO zbira te podatke za vseh 30 centrov v državi, a jih javno ne objavlja po posameznem centru [9] — težava torej ni le lokalna, temveč sistemska.

▼ [Prikaži priporočila za CKZ](#)

ROK	PRIPOROČILO
Kratkoročno	Objaviti letni povzetek dosega (delavnice, posveti, udeleženci); popraviti zastarelo povezavo na "Skupaj za zdravje"; objaviti urnik v berljivi obliki namesto slike.
Srednjeročno	Enotna kadrovska postavka z jasno imenovanim vodjo; redno letno poročanje občinama Črnomelj in Semič; ciljna evalvacija povezave med aktivnostjo CKZ in NIJZ kazalniki.
Dolgoročno	Vključitev v nacionalni benchmarking 30 centrov, če ga NIJZ pripravi; dolgoročno spremljanje učinka na obolevnost/umrljivost občine.

Vir: Zdravstveni dom Črnomelj (uradna stran CKZ in letno poročilo 2025), NIJZ. Polni zapis z vsemi 16 viri in 12 kritičnimi vprašanji: wiki stran *Center za krepitev zdravja (CKZ) Črnomelj*.

11 V evropskem ogledalu

Slovenska primerjava sama po sebi je le del slike — pri več kazalnikih je namreč **Slovenija sama že nad povprečjem EU**, kar pomeni, da je razkorak Občine Črnomelj do evropskega povprečja še večji, kot ga izkazuje zgolj nacionalna primerjava [15]. Spodnja tabela je bila 19. 9. 2026 preverjena neposredno proti celotnemu besedilu primarnega vira [15] (prej dostopnega le prek iskalnih izsekov), kar je popravilo eno prejšnjo trditev — glej opombo pod tabelo.

KAZALNIK	OBČINA ČRNOMELJ	SLOVENIJA	EU POVPREČJE
Dnevni kadilci, odrasli	23,7 % (NIJZ, 2021)	17 % (OECD/EHIS, 2019)	19 % (2019) — Slovenija pod povprečjem
Debelost odraslih (ITM≥30)	—	18 % (2022)	15 % — Slovenija nad povprečjem
Umrljivost zaradi samomora (/100.000)	17,1	15 (2022) — 5. vodilni vzrok preprečljive smrti	10,2 (Eurostat, 2021–22)
Zdravniki na 1.000 prebivalcev	—	3,5 (2023)	4,3 — Slovenija med najnižjimi v EU
Psihiatri na 100.000 prebivalcev	—	17	20
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu	—	82,3 leta (2024, zgodovinski rekord)	nižja od slovenske

Slovenija ima torej hkrati **rekordno visoko pričakovano življenjsko dobo** in **eno najnižjih gostot zdravnikov v EU** — navidezno protislovje, skladno z že dokumentiranim strukturnim pomanjkanjem kadra v ZD Črnomelj; enak vzorec velja za psihiatre (17 proti 20/100.000), kar je pomembno za oceno dispanzerja za duševno zdravje. Pri kajenju je slika ugodnejša, kot bi pričakovali: nacionalni OECD podatek za Slovenijo (17 %) je pod povprečjem EU (19 %), medtem ko je Občina Črnomelj (23,7 %, drugačen vir/leto) občutno nad obema — kazalnika nista neposredno primerljiva zaradi razlike v virih/letih.

Popravek (19. 9. 2026): prejšnja različica tega poročila je trdila, da ima Slovenija "najvišjo stopnjo samomorov v EU", sklicujoč se na starejši Eurostat vir (18,3–19,8/100.000). Neposredno branje primarnega OECD/European Observatory besedila [15] navaja nižjo, a še vedno visoko stopnjo (15/100.000, peti vodilni vzrok preprečljive smrti), brez eksplicitne trditve o najvišjem mestu v EU. Obeh virov ni bilo mogoče dokončno uskladiti (verjetno različna metodologija/leto) — trditev o "najvišji v EU" je zato umaknjena kot nepotrjena, medtem ko dejstvo, da je stopnja znatno nad povprečjem EU (10,2/100.000), ostaja potrjeno v obeh virih.

Podroben razdelek s polnimi metodološkimi opombami: wiki stran *Zdravje v Občini Črnomelj — primerjava s Slovenijo in Evropsko unijo*.

12 Zaključek in priporočila

Zdravje v Občini Črnomelj ni ena zgodba, temveč vsaj tri: **trdovraten problem** pri prekomerni prehranjenosti otrok in splošni umrljivosti, ki v desetletju nista pokazala pravega izboljšanja; **presenetljivo uspešen preobrat** pri srčni kapi, možganski kapi in z alkoholom pripisljivih boleznih; ter **vodilno dobro prakso** pri presejanju raka dojke (DORA). Priporočilo tega poročila ni "narediti več na splošno", temveč razumeti, kaj je pripeljalo do drugega in tretjega vzorca, in to sistematično prenesti na prvega.

Literatura (IEEE)

- [1] "Zdravje v občini — Črnomelj: časovne vrste kazalnikov 2016–2026," Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), portal obcine.nijz.si/obcine/crnomelj, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://obcine.nijz.si/obcine/crnomelj/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [2] "Kako 'zdrave' so belokranjske občine?," Radio Odeon (M. N.), 17. april 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/kako-zdrave-so-belokranjske-obcine/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [3] Zdravstveni dom Črnomelj, Letno poročilo za leto 2025, interno javno objavljeno poročilo javnega zavoda, 2026.
- [4] "CKZ," Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/>. [Dostopano: 6. julij 2026].
- [5] "Dogodki in aktivnosti — Center za krepitev zdravja Črnomelj," Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/dogodki/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [6] "CKZ vabila (arhiv objav)," Zdravstveni dom Črnomelj, 2019–2022. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/blog/category/ckz-vabila/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [7] "Festival zdravja Črnomelj — od ponedeljka 7.4. pa vse do sobote 12.4.2025," Koronarno društvo Dolenjske in Bele krajine, april 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://koronarnodrustvo-dbk.si/festival-zdravja-crnomelj-od-ponedeljka-7-4-pa-vse-do-sobote-12-4/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [8] "Festival zdravja — Dan gibanja, zaključek festivala, svetovni dan zdravja," Radio Odeon, april 2023. [Na spletu]. Dostopno: <https://radio-odeon.com/koledar-dogodkov/festival-zdravja/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [9] "Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja (ZVCT)," NIJZ, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://nijz.si/podatki/podatkovne-zbirke-in-raziskave/zdravstvenovzgojni-centri-centri-za-krepitev-zdravja-zvct/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [10] "Zdravje — Za občane," Občina Črnomelj, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.crnomelj.si/sl/za-obcane/zdravje/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [11] "O projektu SOPA," SOPA, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://sopa.si/sopa-kaj-je-to/o-projektu-sopa/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [12] "Zdravstveni dom Črnomelj — CKZ," Program MIRA, b.d. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.zadusevnozdravje.si/vir-pomoci/zdravstveni-dom-crnomelj-ckz/>. [Dostopano: 19. september 2026].
- [13] "Overweight and obesity — BMI statistics," Eurostat. [Na spletu]. Dostopno: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics. [Dostopano: 20. julij 2026]. Starejši vir (2022 podatek); glej [15] za neposredno preverjen, novejši podatek o debelosti.
- [14] "Deaths by suicide in the EU down by 13 % in a decade," Eurostat, 2024. [Na spletu]. Dostopno: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/edn-20240909-1>. [Dostopano: 20. julij 2026]. Starejši vir (trditev "najvišja v EU" ni bila potrjena v [15] — glej popravek v razdelku 11).
- [15] "State of Health in the EU — Slovenia Country Health Profile 2025," OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, december 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/country-health->

profile-2025-country-notes_7e72146d/slovenia_27d174ae/4765833c-en.pdf. [Dostopano: 19. september 2026, celotno besedilo neposredno prebrano prek PyMuPDF ekstrakcije].

[16] "Obesity rate in the EU: 16.3 % in 2025," Eurostat, 4. september 2026. [Na spletu]. Dostopno:

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260904-1>. [Dostopano: 19. september 2026]. Novejši EU-agregatni podatek (celotna EU, ne le Slovenija) — orientacijski, ni v tabeli razdelka 11 zaradi drugačne enote (obesity/pre-obesity razrez namesto overweight).

[17] Poln zapis s še 5 dodatnimi viri (16 skupaj) o CKZ: wiki stran *Center za krepitev zdravja (CKZ) Črnomelj*, wiki/entities/institutions/ckz-crnomelj.md.

Pripravljeno 19. 9. 2026 · LLM Wiki agent za Občino Črnomelj · wiki/topics/social-affairs/zdravje-obcina-nijz-trendi.md